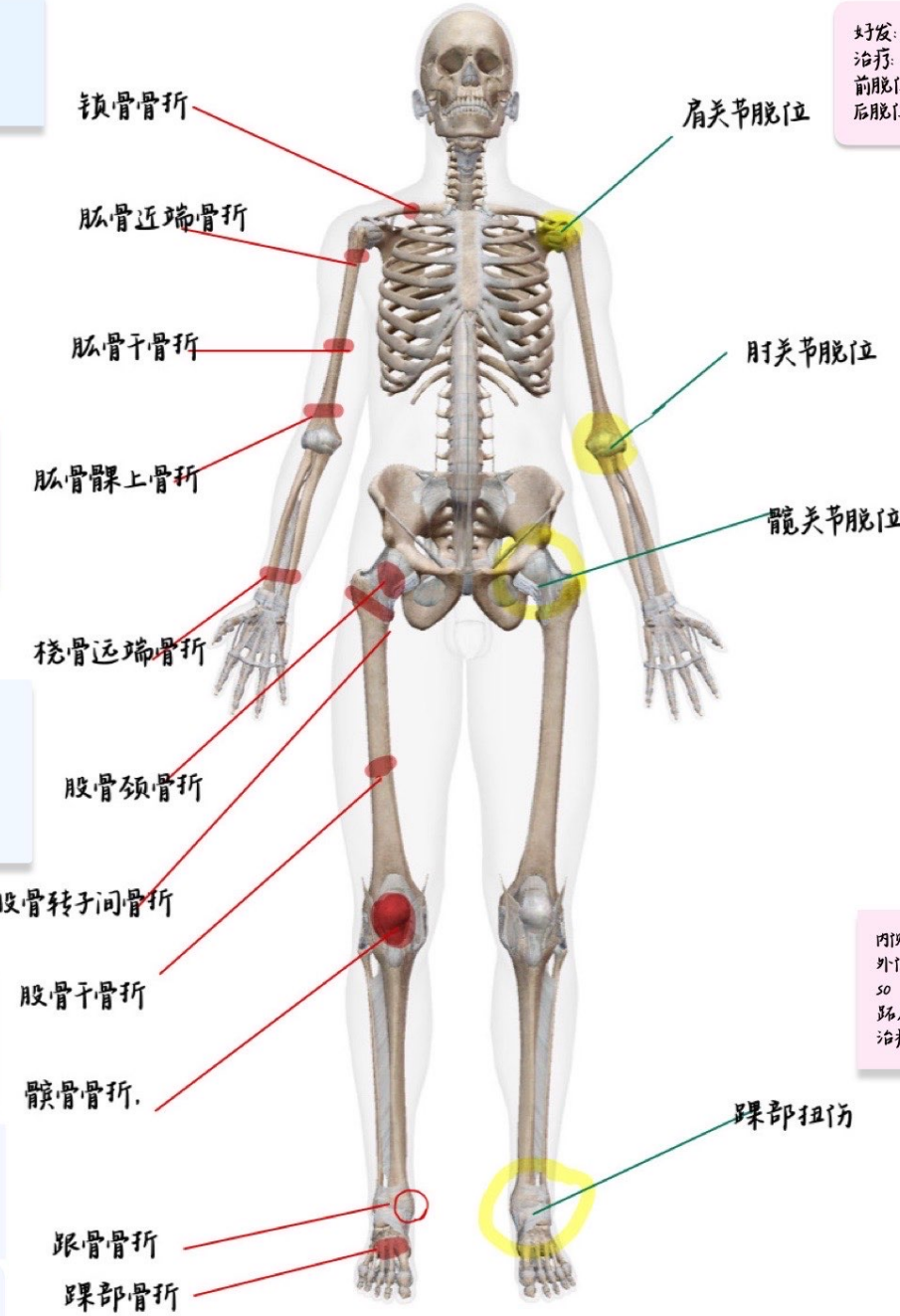
6.9 四肢骨折和脱位



好发：锁骨中1/3
治疗：
1、儿童青枝、成人无移位：三角巾悬吊6个月
2、中段有移位：手法复位+8字绷带外固定

好发：外科颈
分型：Neer分型（移位>1cm 或成角>45°）
治疗：1Neer I型和轻度II型(无移位)：三角巾悬吊
2Neer 重度II、III型：切开复位+钢板内固定
3老年：Neer IV型做人工肱骨头置换术；全身情况差用三角巾悬吊

治疗：
骨折线在三角肌止点以上：内收位牵引
骨折线在三角肌止点以下：外展位牵引

多见于<10岁
伸直型肱骨髁上骨折常见：近折端向前下、远折端向后上移位
屈曲型肱骨髁上骨折：近折端向后下、远折端向前移位

1.Colles 骨折：come 手背离得远
2Smith 骨折：手背着地，stop 手掌离得远
3Barton 骨折：关节面骨折伴腕关节脱位
治疗：手法复位+外固定(Colles 骨折-屈腕尺偏位石膏)

(1)首选手法复位+螺钉内固定
(2)老年
1全身情况差：皮/骨牵引 6~8 周，待全身情况允许后尽快手术
2合并症多预期寿命短：半髋关节/股骨头置换术 减少创伤
3合并症少预期寿命长的 GardenIII/IV(有移位)：全髋关节置换术

转子间压痛，下肢缩短、外旋畸形(可达 90°)，髋部肿胀和瘀斑多见
下肢缩短：NBS

治疗
1新生儿：患肢用绷带固定于胸腹部
2<3 岁：垂直悬吊皮牵引
3>3 岁：手术

保守：无移位、有移位横形骨折<0.5cm：膝关节伸直位固定 手外伤在握球位固定
手术：1有移位横形骨折>0.5cm
2严重粉碎骨折无法恢复软骨面完整：摘除髌骨、修补韧带

内踝外翻45后

1.好发于跟骨后端 2.临床表现：跟骨结节关节角/Bohler 角改变

好发：前脱位（喙突下脱位最常见）
治疗：
前脱位：Hippocrates 足蹬法+三角巾悬吊 3 周(关节囊破损明显→搭肩位肩肱韧带)
后脱位：手术

好发：后脱位多见
临床表现：
1肩后三角关系改变（特征）
2肩后空虚感
治疗：手法复位+外固定

好发：后脱位(中心脱位最凶险)
分型：Epstein分型
后脱位：屈曲、内收、内旋，下肢缩短NBS
前脱位：屈曲，外展，外旋，下肢不定
治疗：
后脱位EpsteinI型：Allis提拉+皮牵引/丁字鞋（全麻或腰麻）
后脱位EpsteinII~V型、中心脱位：切开复位+内固定

内侧副韧带：最强
外侧副韧带：最薄弱
so
跖屈位易发生
治疗：急性期立即冷敷

图源25考研(9版)ttsx讨论帖某同学评论，仅供参考